TSIFRA S.R.L.
Rivista di ricerca interdisciplinare (Demo)
Vol. 1, n. 2 (2025)
pp. 11–13 · ISSN 0000-0000 (online)

ARTICOLO DI RICERCA

Il ricorso alla telemedicina tra gli anziani nei piccoli centri urbani: uno studio a metodi misti

Olga Vasilenko[1], **Miroslav Jovanović**[2✉], **Natalia Arkadyeva**[1]

[1] Istituto di ricerca sulla salute pubblica «Vita», Russia

[2] Centro danubiano di ricerca sulla salute della popolazione, Serbia

✉ Autore di riferimento: Miroslav Jovanović, m.jovanovic@example.org

Ricevuto: 4 marzo 2025 **Accettato:** 15 luglio 2025 **Pubblicato:** 25 settembre 2025

ABSTRACT

I teleconsulti medici possono migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria per i residenti anziani dei piccoli centri, dove la carenza di medici specialisti è particolarmente acuta. Tuttavia, il ricorso a tali servizi da parte delle persone anziane rimane basso e le ragioni non sono ancora sufficientemente comprese. Il presente studio a metodi misti analizza i fattori associati all'uso della telemedicina tra le persone di età pari o superiore a 60 anni in quattro piccoli centri anonimizzati. La fase quantitativa ha previsto un'indagine telefonica su 812 rispondenti; la fase qualitativa è consistita in 28 interviste semistrutturate con pazienti e 9 interviste con operatori sanitari. Nell'ultimo anno il 19% dei rispondenti aveva utilizzato servizi di telemedicina. In un modello logistico multivariabile la probabilità di utilizzo è risultata associata al possesso di uno smartphone, alla convivenza con familiari più giovani e alla presenza di patologie croniche che richiedono un monitoraggio regolare, mentre l'associazione con l'età si è attenuata dopo l'aggiustamento per questi fattori. Le interviste hanno evidenziato tre barriere principali: la sfiducia nella valutazione a distanza dello stato di salute, la complessità delle procedure di prenotazione e di autenticazione e il timore di far perdere tempo al medico senza una visita in presenza. Gli operatori sanitari hanno osservato che la telemedicina è più utile per le visite di controllo e per l'aggiustamento della terapia. Se ne conclude che interfacce semplificate e il supporto del personale infermieristico potrebbero ampliare in modo sostanziale l'uso della telemedicina tra gli anziani.

Parole chiave: telemedicina; anziani; piccoli centri urbani; divario digitale; metodi misti

Telemedicine Uptake among Older Adults in Small Towns: A Mixed-Methods Study

Olga Vasilenko[1], *Miroslav Jovanović*[2✉], *Natalia Arkadyeva*[1]

[1] Vita Research Institute of Public Health, Russia

[2] Danube Centre for Population Health Research, Serbia

ABSTRACT

Telemedicine consultations can improve access to healthcare for older residents of small towns, where the shortage of specialist physicians is particularly acute. However, uptake of such services among older people remains low, and the reasons are insufficiently understood. This mixed-methods study analyses the factors associated with telemedicine use among people aged 60 and over in four anonymised small towns. The quantitative phase comprised a telephone survey of 812 respondents; the qualitative phase consisted of 28 semi-structured interviews with patients and 9 interviews with healthcare workers. Over the past year, 19% of respondents had used telemedicine services. In a multivariable logistic model, the probability of use was associated with smartphone ownership, living with younger relatives and having chronic conditions requiring regular monitoring, whereas the association with age weakened after adjustment for these factors. Interviews revealed three key barriers: distrust of remote assessment of health status, complex booking and authentication procedures, and a fear of wasting the doctor's time without an in-person visit. Healthcare workers noted that telemedicine is most valuable for follow-up consultations and adjusting treatment. We conclude that simplified interfaces and support from nurses could substantially broaden telemedicine use among older adults.

Keywords: telemedicine; older adults; small towns; digital divide; mixed methods

Distribuito con licenza CC BY 4.0

Come citare: Vasilenko O., Jovanović M., Arkadyeva N. Il ricorso alla telemedicina tra gli anziani nei piccoli centri urbani: uno studio a metodi misti. *Rivista dimostrativa su Open Journal Systems* 2025;1(2):11–13.

1 INTRODUZIONE

I piccoli centri soffrono di una carenza persistente di medici specialisti e i residenti anziani devono spesso recarsi nei capoluoghi regionali per le visite. La telemedicina, sotto forma di consulti video o telefonici con i medici, è stata promossa come strumento per colmare questo divario e l'infrastruttura per i consulti a distanza si è notevolmente ampliata dopo il 2020.

Ciononostante, gli anziani, che potrebbero trarne i maggiori benefici, utilizzano la telemedicina meno degli altri gruppi di età. Le spiegazioni si concentrano di solito sulle competenze digitali, mentre minore attenzione è stata dedicata agli atteggiamenti, alla situazione familiare e all'organizzazione dei servizi. Il presente studio combina dati di indagine e interviste per offrire un quadro più completo del ricorso alla telemedicina tra i residenti anziani dei piccoli centri.

2 MATERIALI E METODI

La fase quantitativa è consistita in un'indagine telefonica assistita da computer (CATI) condotta nel periodo marzo–maggio 2024 in quattro centri con una popolazione compresa tra 18.000 e 45.000 abitanti (codificati T1–T4). Un campione casuale di numeri fissi e mobili ha prodotto 812 interviste complete con residenti di età pari o superiore a 60 anni (tasso di risposta 37%). L'esito principale era l'utilizzo della telemedicina negli ultimi 12 mesi; le covariate comprendevano caratteristiche demografiche, stato di salute, possesso di dispositivi e composizione del nucleo familiare.

Nella fase qualitativa hanno partecipato a interviste semistrutturate 28 partecipanti all'indagine (14 utilizzatori e 14 non utilizzatori) e 9 operatori sanitari. Le trascrizioni sono state sottoposte ad analisi tematica da due ricercatori in modo indipendente e le discrepanze sono state risolte mediante discussione.

3 RISULTATI

Complessivamente, il 19% dei rispondenti ha dichiarato almeno un consulto di telemedicina nell'ultimo anno. Il ricorso era più elevato tra le persone con patologie croniche che richiedono controlli regolari (27%) e più basso tra chi vive da solo senza smartphone (6%) (fig. 1).

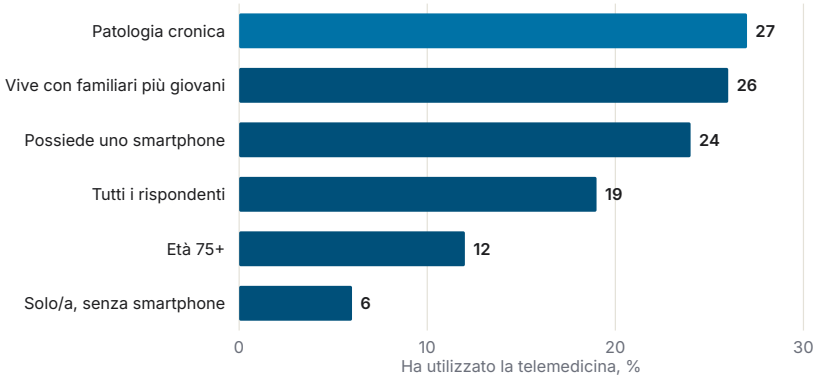


Fig. 1. Utilizzo della telemedicina negli ultimi 12 mesi per gruppo di rispondenti, %

La tabella 1 presenta gli odds ratio aggiustati. Il possesso di uno smartphone più che triplicava la probabilità (odds) di utilizzo e la convivenza con familiari più giovani la raddoppiava. L'effetto dell'età si attenuava e perdeva significatività statistica dopo l'aggiustamento per il possesso di dispositivi e la composizione del nucleo familiare.

Distribuito con licenza CC BY 4.0

Tabella 1. Fattori associati all'utilizzo della telemedicina (regressione logistica, n = 812)

Fattore	OR aggiustato	IC 95%	p
Possiede uno smartphone	3.4	2.1–5.5	<0.001
Vive con familiari più giovani	2.0	1.3–3.0	0.001
Patologia cronica, monitoraggio regolare	1.8	1.2–2.7	0.004
Età (per 5 anni)	0.89	0.76–1.04	0.140
Sesso femminile	1.1	0.8–1.6	0.520

4 DISCUSSIONE

Le interviste hanno aiutato a interpretare queste associazioni. I familiari più giovani fungevano spesso da intermediari, prenotando i consulti e configurando i dispositivi. I non utilizzatori esprimevano frequentemente il dubbio che un medico potesse valutare le loro condizioni senza una visita, e diversi hanno riferito la sensazione che un consulto a distanza avrebbe gravato su un medico già oberato di lavoro.

Gli operatori sanitari consideravano la telemedicina particolarmente utile per le visite di controllo e per l'aggiustamento della terapia farmacologica, e hanno suggerito che il personale infermieristico potrebbe aiutare i pazienti a collegarsi dall'ambulatorio o da casa. Questi risultati indicano la necessità di soluzioni organizzative piuttosto che puramente tecnologiche.

5 CONCLUSIONI

Il ricorso alla telemedicina tra gli anziani dei piccoli centri è limitato meno dall'età in sé che dall'accesso ai dispositivi, dal sostegno familiare e dalla fiducia. Procedure di prenotazione semplificate e consulti facilitati dal personale infermieristico rappresentano vie promettenti per ampliarne l'utilizzo.

BIBLIOGRAFIA

1. Creswell J. W., Plano Clark V. L. Designing and Conducting Mixed Methods Research. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE, 2017. 492 p.
2. Braun V., Clarke V. Using thematic analysis in psychology // Qualitative Research in Psychology. 2006. Vol. 3, no. 2. P. 77–101.
3. Vasilenko O. P., Arkadyeva N. S. Access to specialist care in small towns: a regional survey // Public Health Perspectives. 2022. Vol. 11, no. 3. P. 201–214.
4. Jovanović M., Petrović S. Digital health literacy among older Europeans // Ageing and Technology. 2021. Vol. 6, no. 1. P. 15–33.
5. Hale R., Moreno C. Barriers to video consultations in rural primary care: a qualitative synthesis // Rural Health Review. 2022. Vol. 14. P. 88–104.
6. Аркадьева Н. С. Телемедицина в системе первичной медико-санитарной помощи: организационные модели // Здравоохранение и общество. 2023. № 2. С. 26–41.
7. Lindholm K., Saar T. Nurse-facilitated telehealth for older patients: a pilot evaluation // Journal of Community Nursing Research. 2020. Vol. 9, no. 4. P. 310–322.
8. Vasilenko O. P. Chronic disease monitoring and remote consultations: early evidence // Digital Health Notes. 2023. Vol. 2. P. 40–52.

Distribuito con licenza CC BY 4.0